

TEMA 2.14 • TRAUMATOLOGÍA

Artrosis Y Monoartritis

PERFIL EUNACOM 1.02.14

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las patologías osteomusculares no traumáticas representan una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria. Como médico general, el objetivo es diferenciar cuadros mecánicos de inflamatorios, identificar signos de alarma y manejar el tratamiento inicial de forma efectiva.

Lumbago y Lumbociática

El **lumbago** se define simplemente como dolor en la zona lumbar. La causa más frecuente es el **lumbago mecánico**, secundario a debilidad de la musculatura axial (lumbar y abdominal), lo que genera posiciones viciosas e irritación de estructuras articulares o musculares.

Características Clínicas

- **Lumbago Mecánico:** Aumenta con el movimiento y disminuye con el reposo. - **Lumbago Inflamatorio:** Aumenta con el reposo y disminuye con el ejercicio (sugiere **Espondiloartritis**). -

Lumbociática: Dolor lumbar irradiado a las extremidades inferiores. El manejo inicial es idéntico al lumbago simple.

Manejo Inicial

El tratamiento se basa en tres pilares: 1. **Reposo relativo:** Evitar el reposo en cama prolongado; se prefiere mantener actividad según tolerancia. 2. **AINes:** Manejo analgésico de primera línea. 3. **Kinesioterapia:** No se realiza en la fase aguda. Se inicia cuando el dolor ha cedido para fortalecer la musculatura y prevenir recurrencias.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La simple irradiación del dolor a la pierna (lumbociática) **no** es un signo de alarma ni indicación inmediata de cirugía. La mayoría resuelve con tratamiento médico.

Signos de Alarma (Red Flags)

Ante la presencia de estos signos, el estudio de elección es la **Resonancia Magnética (RM)**. Si no hay signos de alarma, no se solicitan imágenes.

TABLA 2.14.1: CATEGORÍA DE SOSPECHA VS HALLAZGOS CLÍNICOS / ANTECEDENTES

CATEGORÍA DE SOSPECHA	HALLAZGOS CLÍNICOS / ANTECEDENTES
Fractura	Trauma reciente, uso crónico de corticoides, osteoporosis, adulto mayor.
Cáncer	Antecedente de neoplasia, baja de peso inexplicable, dolor nocturno persistente.
Infección	Fiebre, uso de drogas IV, Espondilodiscitis (fiebre + clínica de lumbociática).
Compromiso Neurológico	Paresia (baja fuerza), hipoestesia, abolición de reflejos, síndrome de cola de caballo.
Evolución	Dolor que persiste > 6 semanas o que empeora tras 2 semanas de tratamiento.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La indicación de cirugía en una hernia del núcleo pulposo (HNP) no es el hallazgo en la imagen, sino la **falla al tratamiento médico** o el **compromiso neurológico progresivo**.

Cervicalgia y Cervicobraquialgia

El dolor cervical y su irradiación al brazo (**cervicobraquialgia**) se comportan de manera análoga al lumbago. El diagnóstico es clínico,

el manejo es conservador (AINes + Kine) y solo se estudian con imágenes si presentan signos de alarma neurológicos o sistémicos.

Hombro Doloroso

La causa más común es el **Síndrome de Manguito Rotador**.

- **Clínica:** Dolor que aumenta con movimientos repetitivos, más intenso en la noche. Duele especialmente a la abducción y extensión contra resistencia.
- **Diagnóstico:** Clínico. El examen de elección para objetivar la inflamación es la **Ecografía** (más costo-efectiva que la RM).
- **Tratamiento:** Reposo, AINes y kinesioterapia motora.

Capsulitis Adhesiva (Hombro Congelado)

Es una inflamación de la cápsula articular que lleva a una restricción severa del movimiento. - **Clínica:** Dolor que impide la movilidad **tanto activa como pasiva**. Evoluciona de una fase dolorosa a una fase de anquilosis (rigidez sin dolor). - **Tratamiento:** A diferencia del manguito rotador, aquí se utilizan **corticoides** (sistémicos o infiltración) y kinesioterapia intensiva.

Codo Doloroso

Las causas principales son las entesitis (inflamación de la inserción del tendón):

- **Epicondilitis Lateral (Codo de Tenista):** Dolor en la inserción de los músculos **extensores** del antebrazo (cara lateral).
- **Epitroclitis o Epicondilitis Medial (Codo de Golfista):** Dolor en la inserción de los músculos **flexores** (cara medial).

Tratamiento: Reposo, AINes, kinesioterapia y el uso de una **epicondilara** (banda de descompresión) para liberar tensión en la entesis.

Tendinitis y Bursitis

Tendinitis Específicas

Se caracterizan por dolor a la palpación y al estiramiento del tendón involucrado.

- **Pata de Ganso:** Dolor en la zona anteromedial e inferior de la rodilla. Común en montañismo/trekking.
- **Rotuliana:** Dolor en la tuberosidad tibial. Incluye la enfermedad de **Osgood-Schlatter** en adolescentes.
- **Fascia Lata (Síndrome de la Banda Iliotibial):** Dolor en la cara lateral de la rodilla. Típico de corredores ("**rodilla del maratonista**").
- **De Quervain:** Dolor en la zona lateral de la muñeca (extensor corto y abductor largo del pulgar).

Bursitis

Inflamación de la bursa (saco sinovial extraarticular). A diferencia de la tendinitis, suele presentar **eritema y aumento de volumen visible**.

- **Bursitis Olecraniana:** Aumento de volumen en la punta del codo.
- **Bursitis Pterocantérica:** Dolor sobre el trocánter mayor del fémur.
- **Tratamiento:** AINes, frío local y, en casos refractarios, corticoides.

NOTA CLÍNICA

Para diferenciar una **Bursitis** de una **Artritis Séptica**: En la bursitis, la inflamación es superficial y externa a la articulación; en la artritis, hay derrame articular profundo y limitación dolorosa de todo el rango de movimiento.

Fibromialgia

Es un trastorno de sensibilización central caracterizado por dolor crónico generalizado.

Diagnóstico

Es netamente **clínico**. Se basa en: - Dolor a la compresión de **puntos gatillo** (cervical, trapecio, supraespinoso, codos, rodillas, trocánter, glúteos). - Asociación con **astenia** (fatiga), trastornos del sueño y síntomas somatomorfos (como **Síndrome de Intestino Irritable**). - **Laboratorio normal**: VHS y CK deben estar normales.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente con sospecha de fibromialgia presenta **VHS elevada**, sospechar **Polimialgia Reumática**. Si presenta **CK elevada**, sospechar **Polimiositis**.

Tratamiento

1. **Ejercicio**: Fundamentalmente ejercicios de elongación y aeróbicos progresivos. 2. **Moduladores del dolor**: - **Pregabalina** o Gabapentina. - **Antidepresivos Tricíclicos (Amitriptilina)**: Primera línea por costo, aunque con más efectos adversos. - Ciclobenzaprina (relajante muscular) puede ayudar con el sueño.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, la respuesta más correcta sobre el manejo de la fibromialgia suele ser la combinación de **ejercicios de elongación + pregabalina/amitriptilina**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de sesenta y cinco años consulta por dolor en la rodilla derecha de seis meses de evolución que empeora al caminar y mejora con el reposo. La radiografía de rodilla muestra disminución del espacio articular, osteofitos marginales y esclerosis subcondral. Hasta ahora no ha recibido tratamiento. ¿Cuál es el primer escalón terapéutico indicado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artrosis Y Monoartritis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La primera causa es simplemente degenerativa
- con un componente genético más o menos importante,
- Ahora, el diagnóstico habitualmente es con la radiografía,
- El primero y más frecuente es la disminución del espacio articular.
- el tratamiento hay que saberlo bien,
- o sea el tratamiento del artrócie es el para cetamol,
- pero un gramo cada ocho horas, el tratamiento clásico,

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTROSIS Y MONOARTRITIS)**PREGUNTA 1**

Hombre de sesenta y cinco años consulta por dolor en la rodilla derecha de seis meses de evolución que empeora al caminar y mejora con el reposo. La radiografía de rodilla muestra disminución del espacio articular, osteofitos marginales y esclerosis subcondral. Hasta ahora no ha recibido tratamiento. ¿Cuál es el primer escalón terapéutico indicado?

- A)** Corticoides intrarticulares de rodilla derecha
- B)** Reemplazo articular de rodilla derecha
- C)** Paracetamol un gramo cada ocho horas más ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps
- D)** Ibuprofeno más omeprazol como tratamiento de inicio
- E)** Tramadol oral por su mayor eficacia analgésica

PREGUNTA 2

Mujer de cincuenta y ocho años con insuficiencia renal crónica estadio tres y úlcera duodenal activa consulta por artrosis de cadera con dolor que no cede con paracetamol. ¿Cuál es el siguiente paso correcto en el manejo?

- A)** Agregar ibuprofeno más omeprazol como protección gástrica
- B)** Agregar celecoxib, ya que los COX-2 no producen úlcera
- C)** Tramadol oral, saltando el escalón de los AINE por contraindicación
- D)** Corticoides orales en dosis bajas como antiinflamatorio alternativo
- E)** Derivar directamente a cirugía por la complejidad del caso

PREGUNTA 3

Hombre de cuarenta años consulta por dolor agudo e inflamación en la primera articulación metatarsofalángica del pie derecho desde ayer. La punción articular muestra líquido inflamatorio con cristales de elongación negativa. No tiene fiebre. Es el segundo episodio en el último año. ¿Cuál es el tratamiento de mantenimiento más adecuado para prevenir nuevas crisis?

- A)** Colchicina de por vida en dosis altas como profilaxis
- B)** Probenecid para aumentar la excreción urinaria de ácido úrico
- C)** Alopurinol para reducir la producción de ácido úrico
- D)** AINE a dosis plena de manera indefinida para control del dolor
- E)** No se requiere tratamiento adicional tras el segundo episodio

RESUMEN: ARTROSIS Y MONOARTRITIS

A todos, con este video vamos a empezar con el tema de reumatología y los primeros dos temas que vamos a ver son artrosis y la monartrosis, que incluye artrosis por cristales y además la artrosis y séptica. Así que empezamos con artrosis. ¿Qué es una enfermedad degenerativa que va destruyendo el cartilago articular? Y sepan que no hay nada que se pueda hacer para regenerarlo, por si acaso. La primera causa es simplemente degenerativa con un componente genético más o menos importante, pero también hay de tipos secundarias, por ejemplo secundaria de una lesión crónica, una fractura con rasgo interarticular, artrosis y reumatoide, artrosis y séptica, etc. O sea, la artrosis primaria, la que uno habitualmente se aprende o que uno habitualmente ve, pero hay artrosis secundarias a otras enfermedades, ya sea traumática o reumática. ¿Cuál es la clínica? La clínica es dolor, la articulación duele. Ahora, esto puede a su vez evolucionar después a anquilosis, a medida que va pasando el tiempo la articulación se va moviendo menos y eventualmente puede quedar totalmente rígida. En algunas ocasiones puede haber también derrame, que vamos a ver que es un derrame no inflamatorio, pero el dolor es el síntoma. De hecho, que quede muy claro, radiografía alterada, o sea que tenga el daño articular, pero sin dolor eso no es artrosis, ya la artrosis exige que haya dolor. Ahora, el diagnóstico habitualmente es con la radiografía, con la clínica más radiografía, y los hallazgos clínicos.